Anamnesefragen

Was kann ich für Sie tun?
Was führt Sie zu uns?
Seit wann haben Sie diese Schmerzen?
Wo genau haben Sie diese Schmerzen?
Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten?
Gibt es einen Auslöser für die Schmerzen, z. B. nach dem Essen oder bei Bewegung?
Was haben Sie zum Frühstück gegessen?
Sind die Schmerzen dauerhaft da oder gehen sie wieder weg?
Ist es das erste Mal oder hatten Sie früher schon ähnliche Symptome?
Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus, z. B. in den Rücken?
Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind sie kolikartig oder stechend?
Wie stark sind die Schmerzen?
Gibst es etwas, das die Schmerzen verstarkt z.B. Bewegung oder lindert z.B. nach dem Stuhlgang
Haben Sie etwas gegen Schmerzen genommen?
Sin die Schmerzen mit der Zeit schlimmer geworden?
Haben Sie Brustschmerzen oder Luftnot?
Ist Ihnen aufgefallen, dass Sie Herzrasen, Kaltschweiß, Schwindel, Müdigkeit oder eine schnellere Atmung haben?
Ist Ihr Bauch dicker und härter geworden?
Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen?
Wie sieht Ihr Stuhl aus? Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Wann war der letzte Stuhlgang? Gehen Winde ab?
Haben Sie Blähungen oder Völlegefühl?
Haben Sie Probleme beim Wasserlassen?
Haben Sie Fieber?
Haben Sie Schüttelfrost?
Fühlen Sie sich müde?
Wann war die letzte INR-Kontrolle und wie hoch war der Wert?
Haben Sie Hörminderungen?

Am Ende des Gesprachs Aufklarung

Ich habe einen Verdacht auf ein verschlossenes Blutgefäß in Ihrem Bauch (Darminfarkt). Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen.
Ich werde zuerst körperliche Untersuchung machen, dann Blut für das Labor abnehmen. Danach werde ich eine Stuhlprobe und eine Bauchultraschall durchführen. Wissen Sie, was das ist?
Sobald die Ergebnisse vorliegen, bespreche ich mit meinem Oberarzt, dann komme ich zu Ihnen, erzähle Ihnen alles

Sonographie – Ultraschall:
Ein Ultraschall des Bauchraums ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten dauert. Ein Gel wird auf Ihren Bauch aufgetragen und Ihre inneren Organe mit einer Sonde beobachtet.

Haben Sie noch Fragen an mich?

ARZT-ARZT GESPRACH

Guten Tag, Herr Oberarzt, Frau Oberärztin.
Mein Name ist Sümeyra Firat. Heute habe ich eine neue Patientin aufgenommen. Bevor ich meine Patientin vorstelle, möchte ich Ihnen noch etwas Wichtiges mitteilen:
Ich habe einen Anruf aus dem Labor erhalten. Ich soll Ihnen sagen, dass Herr Müller einen Kaliumwert von 2,6 mmol/L hat. Dieser Wert ist deutlich erniedrigt und entspricht einer Hypokaliämie.

Jetzt berichte ich über den Fall meiner Patientin.

Es geht um Frau Gisela Reuters. Sie ist 63 Jahre alt, am 01.02.1959 geboren, 165 cm groß und wiegt 71,3 kg.
Sie stellt sich bei uns wegen seit eineinhalb Stunden bestehender kolikartiger Bauchschmerzen im Bereich des Bauchnabels vor.
Laut Angaben der Patientin sind die Schmerzen nach dem Frühstück plötzlich aufgetreten.
Sie berichtet, dass die Schmerzen nicht ausstrahlen und die Schmerzintensität bei 8–9/10 auf der Schmerzskala liegt.
Sie erwähnt, dass sie seit vier Wochen ähnliche Beschwerden hat. Damals waren die Schmerzen dumpf, diffus und erträglich; seit eineinhalb Stunden sind sie

jedoch unerträglich geworden.
Begleitend klagt sie über Hyperhidrose, Tachykardie und Übelkeit.

Vegetativanamnestisch ergaben sich stressbedingte Diarrhö, arbeitsbedingte Insomnie, eine Gewichtszunahme von 2 kg in drei Monaten sowie eine Menopause seit 12 Jahren.
Bei der Vorerkrankungsanamnese erwähnte sie eine arterielle Hypertonie seit 15 Jahren, Vorhofflimmern seit fünf Jahren, Raucherhusten (V. a. chronische Bronchitis im Rahmen des Nikotinkonsums), Tinnitus seit drei Tagen sowie einen Zustand nach Hepatitis A.
Als Operation gab sie eine Inguinalhernie an, die vor 15 Jahren operiert wurde.

Sie nannte folgende Operation: Inguinalhernie wurde ihr vor 15 Jahren durchgeführt.

Bei der Medikamentenanamnese ergab sich die Einnahme von Beloc-Zok® 95 mg (1-0-0), ASS 100 mg (1-0-0) und Marcumar® (1-0-0). Die genaue Dosierung von Marcumar® ist der Patientin nicht bekannt.
Bei der Allergieanamnese erwähnte sie eine Allergie gegen Penicillin, die sich in Pruritus, Diarrhö, Emesis und Erythemen äußert.
Bei der Noxenanamnese berichtet sie von 72 Packyears sowie einem Glas Wein am Wochenende. Drogenkonsum wird verneint.
Die Familienanamnese ergab einen Myokardinfarkt beim Vater, an dem er im Alter von 89 Jahren verstorben ist, und einen Apoplex bei der Mutter, an dem sie im Alter von 65 Jahren verstorben ist.
Sozialanamnestisch ist sie Landschaftsbaubesitzerin, verheiratet und wohnt mit ihrer Familie zusammen.
Sie hat einen Sohn und treibt keinen Sport.

Verstorben: daha saygın ve tıbbı raporlarda daha sık kullanılır. Hayatını kaybetti gibi bri anlama geliyor. Gestorben. Öldü demek direk.

Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Akutes Abdomen im Rahmen eines Mesenterialinfarkts hin.
Die kolikartigen Bauchschmerzen mit plötzlichem Beginn, die hohe Schmerzintensität sowie die vegetativen Begleiterscheinungen sprechen dafür.
Differentialdiagnostisch kommen eine akute Appendizitis, eine akute Pankreatitis und ein akutes Koronarsyndrom (ACS) in Betracht.

Um die Verdachtsdiagnose zu bestätigen, werde ich zunächst eine körperliche Untersuchung durchführen, die Vitalparameter überwachen und Blut für das Labor abnehmen.
Im Labor würde ich ein großes Blutbild, Entzündungsparameter, Elektrolyte, Nierenwerte, Leberwerte, Cholestaseparameter, Lipase, Amylase, Herzmuskelenzyme, eine BGA (Laktat, Base Excess, pH-Wert), Quick-Wert, INR, PTT, D-Dimer, einen Urinstatus sowie eine Stuhldiagnostik (FOBT – Fecal Occult Blood Test) kontrollieren lassen.

Anschließend werde ich eine Sonographie des Abdomens, ein Röntgen-Abdomen sowie eine CT-Angiographie des Abdomens durchführen und ein chirurgisches Konsil anfordern.
Sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, sollte die Patientin intensivstationär aufgenommen werden.

Als initiale Therapie empfehle ich Nahrungskarenz, das Legen einer Magensonde, Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution sowie die Gabe eines Analgetikums (z. B. Metamizol), eines Antiemetikums und ggf. eines Antibiotikums (z. B. Ciprofloxacin (penicillin allergisinden dolayı und Metronidazol).
Als kausale Therapie kommt eine explorative Laparotomie bzw. eine operative Versorgung in Betracht.

Reaktionen:

Warum fragen Sie nach Drogen?

Weil die Drogen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben können, und ich werde vielleicht Ihnen ein Medikament verordnen

Akutes Abdomen

- **Patient/ Patientin Datum (Vorname, Name, Geb.-Datum)**

Name: Gisela Renters
Alter: 63 Jahre (geb. am 01.02.1959)
Größe: 1,65 m
Gewicht: 71,3 kg

- **Aufnahmegrund/ Diagnose (stichwortartig)**

Hauptbeschwerde:

- seit 1,5 stunden plötzlich aufgetretene, bestehende, progrediente, kolikartige, periumbilikale Schmerzen ohne Ausstrahlung
- Die Schmerzintensität: 8-9/10 nach der NRS
- Auslöser: Verzehr des Frühstücks
- Lindernde Faktoren: keine
- Verstärkende Faktoren: keine
- Ähnliche, aber leichtere postprandiale, dumpfe Schmerzen seit 4 Wo.
- Begleitsymptome:
  Nausea ohne Emesis
  Tachykardie seit 1,5 Stunden

V/A:

Inappetenz
Hyperhidrose
Gewichtszunahme von 2 kg innerhalb 3 Mo.
Stressbedingte Diarrhö
Stressbedingte Insomnie

Gyn:

Menopause seit 12J.
Forcepsentbindung

V/E:

HRST seit 5J.
aHT seit 5J. (kontrolliert, letzte Messung vor 2 Tagen: 130/80 mmHg)
chronischer unproduktiver Husten seit 20 J.
Ikterus vor 10J. nach einer Reise nach Tunesien
Tinnitus seit 3 Tagen (bds, ohne Hörminderung)

M:

Marcumar 1-0-0
Beloc- Zok 95 mg 1-0-0
ASS 100 mg 1-0-0

Vor-op:

Rechtsseitige Inguinalhernie, operiert vor 22 Jahren, komplikationslos.

- **Allergien/ Unverträglichkeiten:**

Penicillin (Pruritus, Diarrhö, Nausea, Emesis)

- **Genussmittel/ Drogen:**
- Nikotinkonsum: 27 Zig./Tag, seit 36 J.
- Alkoholkonsum: 1 Gl. Wein/Wo
- Drogenkonsum: wurde verneint.

- **Sozialanamnese:**
  Landschaftsbaubesitzerin
  verheiratet
  einen gesunden Sohn

- **Familienanamnese:**
  Vater: verst. mit dem 89 Lj. an MI.
  Mutter: verst. Mit dem 65 Lj. an Apoplex

- **Verdachtsdiagnose:**
  Akutes Abdomen im Rahmen einer Hohlorganperforation - Mesenterialinfarkt.

- **Differentialdiagnose**
  Akute Pankreatitis
  Appendizitis

- **weitere Diagnostik**
- KU
- EKG
- Labor: großes BB - CRP - BSG - BZ - Leberwerte - Nierenwerte - Elektrolyte - Amylase und Lipase- Cholestaseparameter - Gerinnungsparameter (Quick-Wert, INR, PTT) - D-Dimer, Laktat, LDH, CK - BGA (Azidose)
- Abdomen-Röntgen
- Rö-Thorax
- Sono-Abd
- Ggf. CT-angio mit KM
- Chirurgisches Konsil

- **Therapievorschläge**
- Intensivstationäre Aufnahme
- Flüssigkeitszufuhr und Elektrolytsubstitution (Infusionstherapie)
- Nahrungskarenz
- Antiemetikum
- Analgetikum (Metamizol) b.B.
- Ggf. Antibiotikum (Ceftriaxon und Metronidazol)
- Ggf. Laparotomie (Unterscheidet sich je nach der Ursache)

Ausstrahlung → Schmerzübertragung vom Ursprungsort an eine andere Stelle
Frage → Einschätzungssystem in der Notaufnahme Sfarbe

(1)

- Hydratation
- Ernährung: BRAT-Diät (Bananen, Reis, Apfelmus, und Toast)
- Medikamente: gegen Durchfall (Racecadotril zB Vaprino), gegen Erbrechen (Dimenhydrinat zB Vomex A)
- Hygiene: regelmässiges Händewaschen
- Zu Hause bleiben (mindestens 48 Stunden)

Was ist Kanzlei? Büro eines Rechtanwaltes (sie bieten Beratungs- und Dienstleistungen in rechtlichen, steuerlichen oder wirtschaftlichen Angelegenheiten an)

→ Agnes, nehmen Sie Alkohol zu sich?
→ Ich möchte die Ursache Ihrer Schmerzen genau abklären. Schmerzmittel können manche Symptome verändern, deshalb untersuchen wir Sie zuerst, aber Sie müssen die Schmerzen nicht aushalten und bekommen auf Wunsch sofort eine Schmerztherapie.

→ Wir machen eine Stuhlkultur. Bei positivem Befund erfolgt ein Antibiogramm. Dabei wird getestet, gegen welche Antibiotika der Erreger sensibel, intermediär oder resistent ist.

11. Mesenterialinfarkt s.87

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

→ Wann war der letzte Stuhlgang?
→ Gehen Winde ab?
→ Wann war die letzte INR-Kontrolle?
→ Wie hoch war der Wert?

Schnell aber deutlich/ manchmal leise

- Gisela Reuters
- 63 J.
- *01.02.1959
- 1,65 m
- 71,3 kg
- Ich möchte dieses Gespräch nicht führen. Warum? Ich möchte lieber einen deutschen Arzt.
  - Ja das ist möglich. Allerdings sind die anderen Ärzte alle beschäftigt, deshalb sollen Sie noch einige Stunden warten bis sie Zeit für Sie haben. Aber ich kann mich jetzt gerne gleich um Sie kümmern.

Ich verstehe Ihren Wunsch sehr gut. Im Moment bin ich für Ihre Behandlung zuständig und wir machen das gemeinsam. Ich spreche gut Deutsch und Sie können alles in Ruhe mit mir besprechen.

In diesem Moment bin ich für Sie verantwortlich/zuständig.

-Hauptbeschwerden

- Bauchschmerzen
  - **Seit 1,5 Stunden (anderthalb Stunde)**
  - **Periumbilikal:** um meinen Bauchnabel
  - **Kolikartig:** wehenförmig
  - **ohne Ausstrahlung**
  - Nach dem Frühstück **(postprandial)**
  - **plötzlich angefangen:** Hatten Sie früher solche Beschwerden?
  - **NRS: 8-9/10**
  - **Seit 4 Wo. dumpfe diffuse progrediente Bauchschmerzen:** seit 4 Wochen habe ich diese Schmerzen, aber anfangs waren sie dumpf, diffus und erträglich. Aber seit 1,5 Stunden sind sie unerträglich geworden!
- **Hyperhidrose:** ich habe auch viel Schweißausbruch
- **Tachykardie:** Herzrasen
- **Nausea:** Übelkeit
- Stuhl- und Windverhalt Blähung?
- Gehen Winde ab? Gasentwicklung

Kotzgeräusche

- Wann war der letzte Stuhlgang?
- Wann war die letzte Mahlzeit? Heute Morgen habe ich meinen Kaffee getrunken und Brot mit Butter gegessen, wie jeden Morgen.
- Was haben Sie als Frühstück gegessen?

-vegetative Symptomatik

- Diarrhö -+ (manchmal wegen Stress) Durchfall Wie oft Durchfall und seit wann?
- Gewichtsveränderung + (Zunahme ca. 2 kg/ 3 Mo.): ich habe in drei Monaten zwei Kilo zugenommen
- Insomnie + (wegen der Arbeit) ich schlaffe nicht gut

-gyn

- Menarche mit 12 LJ.
- Menopause vor 12 J.
- Zangengeburt (Forcepsentbindung) / Vakuumextraktion
  - Mein Sohn wurde mit Zangengeburt geboren, nutzen Sie heutzutage diese Methode noch?
    - Ja, wir **verwenden** diese Methode noch heute. Das ist sehr praktisch, vor allem **bei schwierigen Geburten**, bei denen das Baby seine Mutter nicht verlassen will.

-Vorerkrankungen

- aHT seit 15 J. (Zufallbefund) Zufällig vor der OP
  - Es ist sehr gut, dass wir sie entdeckt haben, so können wir sie kontrollieren.
- HRST (VHF) seit 5 J.: Unregelmäßiger schneller Rhythmus/ Irgendetwas mit Herzrasen und daher nehme ich Marcumar
- Raucher Tussis/ chronischer Husten (V.a. chronische Bronchitis im Rahmen Nikotinabusus)
- Tinnitus (seit 3 T) Ohrgeräusch
  - Hat er etwas mit meinen Beschwerden zu tun? Könnten Sie mir helfen? Das ist sehr unangenehm. Haben Sie Hörminderung?
- Z.n. Hepatitis A
  - Ich hatte Gelbsucht nach einer Reise nach Tunesien

Ich verstehe, dass Sie die Ohrgeräusche als belastend empfinden. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, deshalb kann ich noch keine sichere Aussage treffen. Nach der Untersuchung besprechen wir darüber.

-Vor-OPs

- Inguinalhernie vor 15 J. (komplikationslos): ich hatte einen Leistenbruch

-Medikation

- Beloc-Zok 95 mg 1-0-0 p.o (*Metoprolol*)
- ASS 100 mg 1-0-0 p.o.
- Marcumar unklare Dosis 1-0-0 (*Phenprocoumon i.d.R. von 1,5 bis 3 mg*)
  - Wann war die letzte INR-Kontrolle und wie hoch war sie? Die Kontrolle der Behandlung mit Marcumar? (i.d.R. INR immer zwischen 2.0 und 3.0)

-Allergien

- Penicillin (Pruritus, Diarrhö, Emesis, Erythem): Juckreiz, Durchfall, Erbrechen und Rotehaut

-Noxen

- Tabak: 37 Zig./d seit dem 27 LJ / seit 36 J.
- C2: 1 Gl. Wein am WE
- Drogen:-
  - Warum fragen Sie danach? Wenn ich ja sage, was machen Sie denn?

Weil Drogen Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten haben können, und ich würde Ihnen vielleicht ein Medikament verschreiben. Machen Sie sich keine Sorge, Aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht werde ich diese Information mit niemandem teilen

-Sozialanamnese

3

- Landschaftbaubesitzerin/ Gärtenmeisterin / Gartenlandschaftbau (selbstständig)
- Verheiratet (Silberhochzeit), lebe mit der Familie zusammen
- 1 Sohn (homosexuell/ schwull und verheiratet)
- Kein Sport

Es ist gut, dass Sie offen darüber sprechen. Jeder Mensch hat das Recht, so zu leben, wie er ist. Für uns steht Ihre gesundheitliche Situation im Mittelpunkt.

-Familienanamnese

- Vater: t mit 89 LJ an MI: Herzanfall
- Mutter: t mit 65 LJ an Apoplex: Schlaganfall

(Jeder ist frei, so zu leben, wie er/sie möchte)

⇨ Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit, Ich bin nun mit meinen Fragen fertig.
Ich habe einen Verdacht auf **ein verschlossenes Blutgefäß in Ihrem Bauch (Darminfarkt)**.
Aber das bleibt nur eine Vermutung, deshalb müssen wir weitere Untersuchungen durchführen, um das zu bestätigen. Ich werde Ihnen zuerst Ihren Körper untersuchen. Dann werde ich Ihnen Blut abnehmen.
Danach werde ich eine **Stuhlprobe** und eine **Bauchultraschall** durchführen. Wissen Sie, was das ist?

Sonographie – Ultraschall:
Ein Ultraschall des Bauchraums ist eine schmerzfreie und strahlenfreie Untersuchung, die etwa 15 Minuten dauert. Ein Gel wird auf Ihren Bauch aufgetragen und Ihre inneren Organe mit einer Sonde beobachtet.

-Fragen

- Was habe ich?
- Muss ich hier bleiben?
- Wie lange dauern die Untersuchungen?
- Was machen Sie jetzt?

Arzt-Arzt-Gespräch

Guten Tag. Mein Name ist Masson. Ich arbeite seit kurzem als Assistenzärztin in der Ambulanz/Notaufnahme.

Es geht um **Frau Gisela Reuters, 63** Jahre alt, die in leicht reduziertem AZ (Allgemeinzustand) und gutem EZ (Ernährungszustand) gekommen ist.

Sie beschreibt Ihre aktuellen Symptome wie folgt: seit anderthalb Stunde kolikartige periumbilicale Schmerzen, ohne Ausstrahlung, die plötzlich nach dem Frühstück begonnen haben. Seit 4 Wochen, berichtet sie ähnliche Beschwerden aber dumpfe, diffuse und progrediente. Jetzt 9 von 10 auf einer Schmerzskala.

Begleitend sind Schweißausbruch, Tachykardie und Nausea.

Sie berichtet auch stressabhängige Diarrhoe und Insomnie, unwillkürliches Gewicht zunahmen von 2 kg in der letzten 3 Monaten. **Ansonsten ist die weitere vegetative Anamnese unauffällig.**

Sie leidet seit 15 Jahren an arterielle Hypertonie und nimmt regelmäßig dagegen Metoprolol ein. Und seit 5 Jahren an Vorhofflimmern (= artiale Fibrillation) und nimmt Phenprocoumon dagegen ein. Sie nimmt auch ASS 100 mg regelmäßig.

Sie ist allergisch gegen Penicillin.

Die Patientin raucht 70 p.y. (37 Zig. pro Tag seit 36J.) und hat dabei einen chronischen Husten.

In der Familienanamnese gibt es Myokardinfarkt und Apoplex.

Das wäre zunächst dem Relevanten.

Aufgrund der Anamnese habe ich den Verdacht auf Mesenterialinfarkt. An Differentialdiagnosen sind zu nennen, **Akute Pankreatitis**, **Nierenkolik / Ureterolithiasis**, **Aortenaneurysma** (Blutung im Bauchraum), **ACS**.

Als erstes werde ich eine körperliche Untersuchung durchführen; dann halte ich eine Laboruntersuchung mit Bestimmung: gr. BB, Entzündungsparameter, Gerinnungsparameter (PT, D-Dimer), Amylase, Lipase, Leber-Nierenwerte, E-lyte, Herzenzyme (Trop.I, T, CKMB), Glukose, **LDH** und **Laktat, INR**.

Anschließend ist eine Duplex-Sonographie des Abdomens. Auch sollte ein Ruhe-EKG durchgeführt werden, um eine kardiale Ursache auszuschließen. Und eine Angiographie, um eine Stenose zu beobachten. Weiterführend ist ein chirurgisches Konsil anzufordern.

Ich werde sie stationäre aufnahmen, in die **Intensivstation**.

Als Therapie bei gesicherter Verdachtsdiagnose empfehle ich eine **explorative Laparoskopie** bzw. Laparotomie (Thrombendarteriektomie und Revaskularisation). Und eine postoperative Antikoagulation mit Heparin, folgend Cumarinderivaten.
Sind Sie mit meinem /diesem Vorgehen einverstanden?

-Fragen

Was spricht für VHF? Sie hat HRST und nimmt regelmäßig Marcumar ein.

- Symptome: Unregelmäßiger Herzschlag, **Palpitationen**, **Schwindel**, Dyspnoe (vegetative Symtptomen wie Schweißausbruch, Zittern/Tremor, Nausea, Emesis)
- EKG: **fehlende P-Wellen**, absoluter **Arrhythmie** (unregelmäßiger RR-Intervalle)

Welche Ursache kennen Sie für VHF?

- Herzklappenfehler (Mitralstenose / Mitralinsuffizienz)
- aHT
- MI
- Herzinsuffizienz
- Hyperthyreose, Störung des Elektrolytenhaushaltes, Alkohol- Cocaïne-konsum, Idiopathisch
- Schlafapnoesyndrom

Komplikationen des VHF? Thrombenbildung und Abgang als Embolie

- Ischämische Apoplexie (CHA_2DS_2-VASc-Score = Congestive heart failure, Hypertension, Age > 75 Jahre, Diabetes, Stroke / TIA, Vascular disease, Age > 65 Jahre, Sex category weiblich)
- Nieren- und Milzinfarkt
- Akute pAVK, Herzinsuffizienz,
- **Mesentrialinfarkt**

Warum hat die Pat. Ohrensausen? = Tinnitus aurium

- aHT
- Morbus Meniere
- Akustikusneurinom
- HWS-Syndrom oder Zahn-Kiefer-Bereich
- Ototoxische Medikamente: Aminoglykoside, Zytostatika, Schleifendiuretika (Furosemid usw.)
- Psychogen

Warum ist ASS keine gute Wahl für Hepatitis? Nach eine Hepatitis A, wird der Leber zusätzlich schäden

Was ist Beloc-zok? Metoprolol, selektiver Beta1-Blocker

Warum ist ASS keine gute Wahl für diese Patientin? Sie nimmt schon Antikoagulantien

Was ist Marcumar? Phenprocoumon, Vitamin-K antagonist (Cumarin Derivate). Der Nachteil von Marcumar ist, dass es eine **regelmäßige Messung des INR-Wertes** erfordert.

Was ist INR? = International Normalized Ratio = standardisierter Quick-Wert zur Verlaufskontrolle einer Antikoagulation mit Vitamin-K-Antagonisten (Phenprocoumon, Warfarin)

- Normwertige INR: 1,0
- Therapeutische INR-Werte, bei medikamentöser Antikoagulation: 2,0-3,0

Wenn erhöht => Vitamin-K-Gabe

Welche Alternativ zu Marcumar gibt es? Direkte orale Antikoagulantien (DOAK) / NOAK (nicht-Vitamin-K-antagonistische Orale Antikoagulanzien)

- Apixaban (Eliquis) = Anti-FXa-Typ (Kaktor-Xa-Hemmer)
- Rivaroxaban (Xarelto)
- Edoxaban (Lixiana)
- Dabigatran (Pradaxa) = Anti-FIIa-Typ (Thrombinhemmer)
- Diese Medikamente haben den Vorteil, dass sie im Gegensatz zu Marcumar **keine regelmäßige INR-Überwachung** erfordern und in der Regel weniger Nahrungs- und Medikamenteninteraktionen aufweisen.

Nebenwirkungen von Marcumar: Blutungen (Nasen, Gastrointestinaltrakt, Gehirn, Nebenniere, Retina), Haarverlust, Urtikaria, Ekzemen, Leberschädigung, zahlreiche Interaktionen (selten: Nekrosen der Haut)

Weitere Nutzungen von Marcumar: Rattengift

Wo genau im Vorhof wird das Blutgerinnsel gebildet? Häufig in den linksatrialen Appendices (= linkes Herzohr), aufgrund der unregelmäßigen und ineffektiven Kontraktionen des Vorhofs

Wie würden Sie die Pat. Im Triage-System einschätzen? Rot, weil Intensivbehandlung erforderlich ist.

Warum EKG? Ein MI könnte sich unter Bauchschmerzen **verstecken**.

Was bedeutet Konsil? ärztliche Beratung

Erhöhte LDH, D-Dimere und Laktat => Welcher Wert ist ein Hinweis auf Nekrose?

- **LDH** = Enzym bei Zellschäden hinweisen
  - Ein erhöhter LDH-Wert im Blut kann auf Zellschäden oder Gewebezerstörung hinweisen, da LDH bei Zellzerfall freigesetzt wird. Erhöhte LDH-Werte können bei einer Vielzahl von Erkrankungen auftreten, darunter Herzinfarkt, Lebererkrankungen, Blutkrankheiten, und Krebs.
- **Laktat** = Stoffwechselprodukt durch Hypoxie hinweisen
  - Ein erhöhter Laktatspiegel im Blut kann auf Sauerstoffmangel (Hypoxie) in Geweben hinweisen, oft verursacht durch intensive körperliche Aktivität, Schock oder andere Erkrankungen, die die Sauerstoffversorgung beeinträchtigen.

Welche Maßnahmen führen Sie durch, wenn Sie die Laborergebnisse abwarten? Ich gebe intravenös Flüssigkeit und Schmerzmittel und beobachte die Vitalzeichen (Monitoring)

Was erwarten Sie bei der Sonographie? Verminderter oder fehlender Blutfluss in den mesenterialen Gefäßen

CT-Angiographie dauert 2 Stunden, sind Sie einverstanden? Der Radiologist hat Ihnen gesagt, dass er 2 Stunden benötigt, um CT durchzuführen. Sind Sie damit zufrieden? Nein ich bin nicht einverstanden. Bei Verdacht auf Mesenterialinfarkt sollte keine Verzögerung der Behandlung in Kauf genommen werden, da dies eine **Notfallindikation** für eine **sofortige chirurgische Intervention** darstellt (explorative Laparoskopie).

Welche laparotomische Befunde bei der Laparotomie? Sichtbare dunkel verfärbte und brüchige Darmsegmente, die auf eine Nekrose hinweisen

Wichtige Laborwerte bei Appendizitis? Leucocyten, CRP. Alvarado-Score:

- Schmerz in den rechten Unterbauch
- Appetitlosigkeit
- Übelkeit und Erbrechen

- druckschmerzhaftigkeit der rechte Unterbauch (2 Punkte)
- Loslassschmerz
- Fieber (ab 37,3 °C)
- Leukozytose über 10.000 /µl (2 Punkte)
- Linksverschiebung im Differentialblutbild

Mesenterialinfarkt

= Mesenterialarterienstenose ist eine Verengung (Stenose) oder kompletter Verschluss einer Mesenterialarterie mit anschließender Infarzierung und Nekrose des versorgten Darmabschnitts.

Ätiologie: in den meisten Fällen durch eine arterielle Embolie oder lokale Thrombose nach dem Truncus coeliacus. Risikofaktor:

- Arteriosklerose
- Vorhofflimmern
- Versorgung eines Bauchaortenaneurysmas

Klinik: 3 Phasen

1) **Initialstadium** (0-6h): abdominelle kolikartige Schmerzen mit Nausea, Emesis, Diarrhö, starke Inappetenz +/- ungewollten Gewichtsverlust (Abdomen klinischen unauffällig)
2) **Latenzstadium** (6-12h) = „trügerischer Frieden": symptomatischen Verbesserung und Meteorismus. In dieser Phase setzt die Wandnekrose ein.
3) **Spätstadium** (> 12h): Peritonitis mit Entwicklung eines Schocks. Klinisch: akutes Abdomen mit Abwehrspannung

Diagnostik:

- KU: Abwehrspannung und bei der Auskultation ❑ fehlende Darmgeräusche
- Labor: LDH und Laktat ↗ (häufig auch Leucoytose)
- Duplex-Sonographie und Angiographie
- Ggf. CT-Angiographie

Therapie:

- Laparoskopie bzw. Laparotomie: Thrombenarteriektomie durch Fogarty-Katheter / Revaskularisation durch Bypass zwischen Aorta und stenosiertem Gefäß
- Postoperative Antikoagulation mit Heparin, folgend mit Cumarinderivaten

12. Akuter schub chronischer Pankreatitis s.97

Arzt-Patient-Gespräch

-Name, Geburtsdatum, Gewicht, Größe

Spricht schnell (insb. Nummern), sehr viel und murmelt ein bisschen

- Dieter Kazmarek / Theo Sarbovski
- 59 J.
- *31.12.1962: Am letzten Tag des Jahres 62
- 1,83 m
- 74,3 kg
- Warum fragen Sie nochmal? Ich habe schon alles bei der Anmeldung gegeben.
  - Das ist wichtig für uns die Daten nochmal überprüfen, um die Patienten nicht verwechseln.

-Hauptbeschwerde

- Meine Kumpels haben mich gezwungen, hierher zu kommen. Sie haben gesagt, es geht nicht mehr. Ich habe Magenschmerzen und in den letzten 2-3 Wo. haben sich die Schmerzen verschlimmert, immer wenn ich etwas esse, bekomme ich sofort Schmerzen, dann trinke ich viel Bier.

Patientin

Rita Schlömer

61 J.

* 30.06.1963

1,65 cm 71,3 kg

Hauptbeschwerden

- seit unterhalb Stunden bestehende, plötzlich postprandial aufgetretene, persistierende, progrediente, koliartige Bauchschmerzen im Periumbilicalbereich.
- Die Schmerzintensität: 8/10 auf der Schmerzskala
- Auslöser: Verzehr von Toast, Marmelade und Kaffee
- ohne Ausstrahlung
- verstärkende Faktoren: Bewegung
- lindernde Faktoren: keine
- ähnliche Beschwerden: seit 4 Wochen, postprandial, leichter
- dicker und harter Bauch

seit 4 Wochen bestehende, postprandiale, leichtere, dumpfe Bauchschmerzen

Begleitsymptome

- Übelkeit seit gestern

vegetative Anamnese

- Inappetenz
- Gewichtsabnahme von 2 kg in 3 Monaten
- stressbedingte Dyssomnie
- Diarrhoe nur bei Stress stressbedingte Diarrhoe
- Nykturie nur wenn sie viel Wasser trinkt

gynäkologische Anamnese

- ~~Menstruation vor 14 Tagen~~ Menopause seit 14 J. • Forceps-Entbindung

Vorerkrankungen

- VHF seit 2 Jahren (INR gut eingestellt, letzte Messung nicht erinnert, aber alles in Ordnung)
- aHT seit 5 Jahren (kontrolliert, letzte Messung: 130/80)
- chronischer unproduktiver Husten seit längerer Zeit (trocken, mmtg, wegen Rauchen)
- Leistenhernie - OP vor 25 J.
- z.n. Hepatitis A vor 20 J. nach einer Reise nach Tunesien

Medikamente

- Marcumar unklare Dosis (1-0-0)
- Beloc-Zok 95 mg (1-0-0)
- ASS 100 mg (1-0-0)

Allergien/Unverträglichkeiten

- Penicillin (Pruritus, Erythem)

Genussmittel

Nikotinkonsum: 35 py (1 Packung täglich seit 35 Jahren)
Alkoholkonsum: 1 Flasche Rotwein am Wochenende
Drogenkonsum: wurde verneint

~~Sozialanamnese~~ Familienanamnese

Vater: verstorben an MI mit 59. Lj.
Mutter: verstorben an Apoplex mit 65. Lj.

Sozialanamnese

- Gartenlandschaftbauer
- Stress bei der Arbeit
- verheiratet
- einen Sohn (homosexuelle Beziehung)

Verdachtsdiagnose

akutes Abdomen im Rahmen einer Mesenterialinfarkt

Differentialdiagnose

- Akute Appendizitis
- akute Pankreatitis
- ACS

weitere Diagnostik

- KU
- Vitalparameter, EKG
- Labor: gr. BB, Entzündungsparameter, LDH, Laktat, Gerinnungsparameter (D-Dimer, INR), BGA, Amylase, Lipase, Cholestasewerte, Herzmuskelenzyme, Nierenwerte, Leberwerte, Elektrolytwerte
- Sonographie - Abdomen
- Röntgen - Abdomen
- ggf. CT - Angiographie - Abdomen
- chirurgisches Konsil

Therapie

- stationäre Aufnahme, Monitoring
- Nahrungskarenz
- Flüssigkeitszufuhr, Elektrolytsubstitution
- symptomatische Behandlung (Analgetikum, Antiemetikum)

(Cephtriaxon, Metronidazol)

- Antibiotikum
- explorative Laparotomie

(entscheidet sich

Heparin

Kan içinde antitrombin III'ü aktive ederek pıhtılaşmanın hızını durdurur.

Dozaltı - sodalı içinde etki başlar

Kısa etkili

IV yolu SC uygulanır

aPTT ile izlenir.

Akut antikoagulan başlangıç tedavisinde

Gebelikte güvenli

Cumarin - Marcumar

Kaçınılacak K vitamini; bağımlı pıhtılaşma faktörlerini bloklar.

Gırtlak C7-halqası'nda vursu

Uzun

Oral

INR

Uzun süreli idame tedavisinde

Güvenlik:

Bridge Behandlung

ilk Gün Heparin başlanır

Aynı zamanda Marcumar (Coumadin) başlanır.

INR terapötik dozu gelince 2–3 arası

Heparin kesilir, Marcumar ile devam edilir

Zur initialen Antikoagulation wird Heparin gegeben und anschließend mit Marcumar fortgesetzt.

→ Der INR ist deutlich erhöht. Bei fehlender Blutung pausieren wir Marcumar und geben niedrig dosiertes Vitamin K zur Verlaufskontrolle

→ Bei erhöhtem INR mit aktiver Blutung geben wir Vitamin K i.v. und Prothrombinkomplex zur schnellen Normalisierung

↓ langsam sanigert

↓ schnell sanigert

→ Der Patient hat vermutlich Rattengift eingenommen. Wegen der Vitamin K Antagonisten kommt es zu einem stark erhöhten INR und Blutungsrisiko

LDH → Hinweis auf Hämolyse oder Kono schädigung, dazu nekrotisch gestuft

Laktat → Hipoxie (Sepsis) ↑ ohne nekrotisch durch gestufungsi dagil

D-Dimer → Antikoagulantien gestu. → Nekrose ohne Thrombose gestufungsi

→ in Kauf nehmen. Gerne ohne Schadl ehrlich

Die Patienten nimmt Nebenwirkung in Kauf.

für die bessere Wirkung nimmt er das Risiko in Kauf

Menière

Die Symptomtrias aus rezidivierenden Vertiginöse Anfällen, Tinnitus und fluktuierender Innenohrschwerhörigkeit spricht für Morbus Menière

Akustikusneurinom

Ein einseitiger progredienter Hörverlust mit Tinnitus und Gleichgewichtsstörungen lässt an ein Akustikusneurinom denken, weshalb eine MRT empfohlen ist.